



Yth.

Seluruh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)

SURAT EDARAN
NOMOR : 1380/I-SE/DIR/XI/2024

TENTANG
TIM KENDALI MUTU KENDAL BIAYA (TKMKB) -JKN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024

Berdasarkan Surat dari BPJS Kesehatan tentang Pengantar Berita Acara Rekomendasi TKMKB Provinsi Jawa Timur 2024 Nomor 4878/VII-05/1024, dengan ini kami sampaikan terkait kasus :

1. Bayi Ikterus
2. Bayi BBLR dengan Asfiksia
3. Pneumonia dan Bronkitis Pada Anak
4. Gangguan Elektrolit Pada Layanan Rawat Inap

Sehubungan dengan Pertemuan TKMKB Prov. Jawa Timur Tahun 2024 yang melibatkan perwakilan Organisasi Profesi, maka dibuat rekomendasi atas permasalahan klaim JKN di Jawa Timur sebagai berikut :

1. BAYI IKTERUS

a. Permasalahan

Klaim bayi ikterus tanpa disertai bukti penunjang pemeriksaan laboratorium kadar bilirubin, melainkan menggunakan pemeriksaan kramer

b. Rekomendasi

1. Pelayanan kasus ikterus neonatorum mengacu pada PNPK Tata laksana Hiperbilirubinemia tahun 2019
2. Hiperbilirubinemia didefinisikan sebagai kadar bilirubin serum total ≥ 5 mg/dL (86 $\mu\text{mol/L}$). Ikterus neonatorum merupakan keadaan klinis pada bayi yang ditandai oleh pewarnaan ikterus pada kulit dan sklera akibat akumulasi bilirubin tak terkonjugasi yang berlebih. Ikterus secara klinis akan mulai tampak pada bayi baru lahir bila kadar bilirubin darah 5-7mg/dL. **Sehingga untuk penegakan diagnosa ikterus diperlukan pemeriksaan kadar bilirubin.**
3. Bagi bayi yang risiko tinggi, seperti inkompatibilitas rhesus, ketidakcocokan golongan darah bayi dan ibu, defisiensi enzim G6PD, asfiksia, bayi tampak sakit, dan kadar albumin rendah, maka rekomendasi fototerapi dapat diberikan dengan mengambil garis 2-3 mg/dL di bawah *cutoff*, sehingga harus ada pengukuran kadar bilirubin.
4. Pemeriksaan kadar bilirubin dapat melalui metode transkutaneus dan/atau serum. Idealnya menggunakan serum untuk pengukuran bilirubin.
5. Penggunaan Kramer **tidak disarankan** karena banyak variasi dan subjektivitasnya, yaitu diantaranya subjektivitas dari warna kulit bayi, dan mata dari pemeriksa/neonatalogis yang berpengalaman beda dengan tenaga medis baru/bidan dll.

2. BAYI BBLR DENGAN ASFIKSIA

a. Permasalahan :

Pada bayi baru lahir dengan kondisi BBLR dan asfiksia, kondisi mana yang menjadi



diagnosautama pada klaim ?

b. Rekomendasi

1. Standar pelayanan Asfiksia mengacu PNPK Tata Laksana Asfiksia tahun 2019,
2. Pendiagnosisan/ pembuktian asfiksia terbagi dalam 2 kondisi yaitu untuk FKRTL yang tersedia fasilitas pemeriksaan analisis gas darah (BGA) dan FKRTL yang tidak tersedia fasilitas pemeriksaan BGA :
 - 1) FKRTL yang memiliki fasilitas pemeriksaan BGA perlu melampirkan hasil tersebut, disertai kriteria klinis lain yang mendukung untuk diagnosis asfiksia, sesuai dengan PNPK / PPK. Pemeriksaan BGA yang dilakukan harus dibuktikan dengan print out hasil pemeriksaan BGA (bukan hasil bacaan yang diketik tenaga kesehatan / ERM).
 - 2) FKRTL yang tidak mampu melakukan pemeriksaan BGA, maka bisa menggunakan gambaran klinis, yaitu 2 dari 3 kriteria klinis dari tabel dibawah ini :

No	Fasilitas ideal *keempat kriteria harus terpenuhi	Fasilitas terbatas *minimal kedua kriteria harus terpenuhi dengan ketidakterersediaan pemeriksaan analisis gas darah
1.	• Bukti asidosis metabolik atau campuran (pH <7.0) pada pemeriksaan analisis gas darah tali pusat atau • Defisit basa 16 mmol/L dalam 60 menit pertama	Bukti riwayat episode hipoksik perinatal (misal episode gawat janin)
2.	Nilai Apgar ≤ 5 pada menit ke-10.	• Nilai Apgar ≤ 5 pada menit ke-10, atau • Bayi masih memerlukan bantuan ventilasi selama ≥ 10 menit
3.	Manifestasi neurologis, seperti kejang, hipotonia atau koma (ensefalopati neonatus);	Manifestasi neurologis, seperti kejang, hipotonia atau koma (ensefalopati neonatus)
4.	Disfungsi multiorgan, seperti gangguan kardiovaskular, gastrointestinal, hematologi, respirasi, atau renal.	Disfungsi multiorgan, seperti gangguan kardiovaskular, gastrointestinal, hematologi, respirasi, atau renal

Sumber : PNPK Asfiksia 2019

3. Diagnosis asfiksia merupakan pembuktian adanya hipoksia pada bayi baru lahir, dengan menggunakan hasil pemeriksaan BGA dan kriteria klinis. Contoh kasus pada BBL dengan kondisi apgar score (AS) <6 pada menit ke 0 dan menit ke 5, namun pada menit ke-10 menunjukkan hasil 6 atau lebih maka tidak dapat ditegakkan diagnosis asfiksia.
4. Sehubungan dengan kondisi Asfiksia pada BBLR, secara medis diagnosis utama adalah masalah utama yang membuat risiko berat terjadinya mortalitas dan morbiditas. Kondisi asfiksia dan BBLR, yang lebih berat adalah asfiksia. Terkait BBLR masih dapat diatasi dengan metode kanguru, apabila tidak ada kondisi lain yang memperberat. Sehingga pada kasus bayi BBLR dengan asfiksia, diagnosa utama adalah asfiksia dan BBLR sebagai diagnosa sekunder.

3. PNEUMONIA DAN BRONKITIS PADA ANAK

a. Permasalahan

1. Tingginya jumlah kasus bronkhitis pada anak yang dirawatinapkan di beberapa RS
2. Meningkatnya jumlah kasus pneumonia pada anak yang dirawatinapkan



b. Rekomendasi

1. ISPA terbagi menjadi infeksi saluran pernapasan atas dan bawah. Bronkitis akut dan pneumonia merupakan ISPA bawah. Data global menunjukkan paska pandemi menunjukkan lonjakan kasus ISPA, terbanyak adalah ISPA atas, yang disebabkan oleh virus. Bila ISPA atas berlanjut menjadi ISPA bawah maka perlu dicari faktor risikonya, seperti riwayat kelahiran prematur, BBLR, malnutrisi, adanya penyakit komorbid seperti kelainan jantung atau lainnya.
2. Data medis yang tidak lengkap pada pengajuan klaim (tidak ada informasi pemeriksaan RR, suhu, HR, saturasi oksigen, dan lain sebagainya) sehingga tidak dapat memenuhi kriteria diagnosis, maka penagihan klaim tidak dapat disetujui.
3. Pneumonia :
 - a) Penegakan diagnosis pneumonia terutama berdasarkan klinis. Gejala klinis pneumonia bervariasi mulai dari yang ringan, sampai mengancam jiwa. **Pneumonia ringan (batuk yang disertai napas cepat/ takipnea) dapat dilakukan rawat jalan.** Batasan napas cepat yaitu usia 0-2 bulan: > 60 x/menit; usia 2-12 bulan: > 50 x/menit; usia 1-5 tahun: > 40 x/menit; usia >5 tahun: > 30 x/menit. Pneumonia berat yang didefinisikan jika pneumonia disertai dengan tanda bahaya memerlukan perawatan di RS yaitu sianosis, dyspnea (chest indrawing / retraksi subkostal, napas cuping hidung), apnea, merintih, penurunan kesadaran, tanda dehidrasi, saturasi oksigen <90% pada udara ruangan. Pneumonia pada bayi muda (usia dibawah 3 bulan) juga merupakan indikasi rawat inap.
 - b) Pemeriksaan penunjang pneumonia sebagai pendukung temuan klinis dilakukan sebagai bagian dari penegakan diagnosis dan mencari komplikasi serta komorbid, pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan laboratorium, mikrobiologi dan radiologis. Pemeriksaan penunjang bertujuan untuk mencari bukti infeksi, etiologi kuman, menentukan berat ringannya penyakit, panduan perawatan, dan pilihan terapi.
 - c) Pulse oximetry harus dilakukan untuk semua anak dengan pneumonia dan curiga hipoksemia. Adanya hipoksemia harus menjadi pedoman untuk menentukan tempat perawatan dan pemeriksaan diagnostik lanjutan.
 - d) Pemeriksaan foto rontgen dada dilakukan pada pasien dengan pneumonia berat (setelah evaluasi di klinik atau instalasi gawat darurat). Pemeriksaan foto rontgen dada ulang dapat dilakukan pada anak yang TIDAK menunjukkan perbaikan klinis dan yang mengalami perburukan klinis dalam jangka waktu 48-72 jam setelah terapi awal. Kultur darah harus dilakukan pada anak yang tidak menunjukkan perbaikan klinis dan yang mengalami perburukan gejala klinis setelah terapi awal antibiotika.
 - e) Anak dengan pneumonia berat harus diterapi dengan antibiotika injeksi ampicilin dan injeksi gentamisin sebagai terapi lini pertama (Ampicilin: 50 mg/kg, IV/IM setiap 6 jam; Gentamisin: 7,5 mg/kg IM/IV sehari sekali). Lama terapi selama 5 hari. Jika gagal terapidengan lini pertama, maka dapat menggunakan lini kedua (Ceftriakson). Terapi suportif meliputi nutrisi, cairan dan oksigenasi. Nebulisasi Short Acting Beta2 Agonis bisa dipertimbangkan diberikan jika dijumpai wheezing yang mengarah ke arah penyerta asma.
4. Bronkitis akut :
 - a) Penyebab bronkitis akut pada anak-anak yang paling umum adalah virus. Pada anak-anak di atas usia 6 tahun, bronkitis akut dapat terjadi setelah infeksi virus lainnya pada saluran pernapasan bagian atas.



- b) Penegakan diagnosis bronkitis terutama berdasarkan klinis. **Bronkitis akut biasanya merupakan kondisi yang ringan sehingga tidak memerlukan rawat inap.**
- c) Indikasi rawat inap jika didapatkan tanda gawat napas (takipnea, retraksi, hipoksemia, sianosis). Terapi bronkitis akut suportif dan simptomatis.
- d) Pemberian antibiotika diindikasikan jika didapatkan batuk produktif lebih 2 minggu yang mengarah ke diagnosis Protracted bacterial bronchitis dengan pilihan antibiotika co amoksislav secara oral selama minimal 2 minggu

4. GANGGUAN ELEKTROLIT PADA LAYANAN RAWAT INAP

a. Permasalahan

- a. Tingginya jumlah kasus gangguan elektrolit pada klaim rawat inap sebagai penambahan diagnosis sekunder di beberapa RS
- b. Gangguan elektrolit meningkatkan severity level penagihan klaim rawat inap

b. Rekomendasi

- a. Gangguan elektrolit Hipo/hiper pada klaim rawat inap yang sepanjang terkait dengan penyakit utama maka harus diterapi sebagai penyakit utama dan tidak bisa menjadi diagnosis sekunder.
- b. Bisa ditagihkan sebagai diagnosa sekunder bila hipo/hiper dengan gangguan fungsi organ sedang/berat (misalnya kejang dan lain-lain) serta mendapat terapi intravena.
- c. Gangguan elektrolit (Hipo/hiper) bila menjadi penyebab gangguan organ lain, maka menjadidiagnosis primer.
- d. Apapun temuan klinis hipo/hiper tetap ditulis namun belum tentu dapat diklaimkan, menyesuaikan kaidah koding yang benar.

Demikian surat edaran ini dibuat, mohon dijadikan perhatian dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 05 November 2024
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah